Expertenblatt A · Hypovolämischer Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

Herr Gerhard Albrecht (81) lebt seit vier Jahren im Pflegeheim „Am Kocherufer“. Wegen eines Vorhofflimmerns nimmt er einen Gerinnungshemmer. Am Vormittag hatte er schwarzen, klebrigen Stuhlgang. Danach hat er mit seinem Zimmernachbarn Karten gespielt.

Als Sie ihn um 11:30 Uhr zum Mittagessen an die Bettkante setzen wollen, sagt er: „Mir wird ganz schwarz vor Augen.“ Er ist blass, seine Stirn ist kalt und feucht. Mehrmals bittet er um etwas zu trinken. Er wirkt unruhig und fragt, wo seine Frau sei, obwohl er sonst gut orientiert ist. Sie messen: Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, Atemfrequenz 24/min. Bei der Morgenrunde lagen die Werte bei Puls 78/min und Blutdruck 145/85 mmHg. Seine Tochter hat sich für den Nachmittag zum Besuch angemeldet.

Informationstext A: Hypovolämischer Schock

Bei einem hypovolämischen Schock ist der Puls schnell und schwach. Die Haut ist blass, kalt und schweißig. Viele Menschen haben großen Durst, sind unruhig oder verwirrt und atmen schnell. Der Blutdruck fällt oft erst spät. Wichtig ist der Vergleich mit dem Vorwert (Schockindex).

Pflegefachpersonen achten darauf, wo Blut verloren geht: Stuhl, Erbrochenes, Verband, Drainage. Sie kontrollieren Puls, Blutdruck, Bewusstsein und Urin im Verlauf.

Ausgelöst wird er durch einen Verlust von Blut oder Flüssigkeit: eine Blutung nach außen oder im Körper, z. B. im Magen-Darm-Trakt, oder starker Durchfall und Erbrechen. Gerinnungshemmer erhöhen das Blutungsrisiko. Schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) zeigt eine Blutung im Magen oder Zwölffingerdarm.

Im Notfall: Hilfe holen. Flach lagern, Beine hoch (ohne Atemnot). Nicht aufsetzen. Wärme erhalten, überwachen.

Im Körper: weniger Volumen → weniger Blut fließt zum Herzen → der Blutdruck droht zu fallen. Der Sympathikus steuert gegen: Der Puls steigt, und die Gefäße in Haut, Niere und Darm werden eng (Zentralisation, siehe Woche 1).

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: hypovolämisch = mit zu wenig Volumen | Teerstuhl = schwarzer Stuhl durch verdautes Blut | Zentralisation = Umverteilung des Blutes zu Gehirn und Herz

Expertenblatt B · Anaphylaktischer Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

Mia (19) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel und mit Ihnen auf einer internistischen Station eingesetzt. In der Pause isst sie ein Stück Geburtstagskuchen, das Haselnüsse enthält. Dabei erzählt sie von ihrem Wochenende im Kletterpark. Mia erwähnt, dass es bei Nüssen „schon mal im Mund gekribbelt“ habe.

Zehn Minuten später kratzt sie sich an Hals und Händen, auf Hals und Brust bilden sich Quaddeln. Ihre Lippen und Augenlider schwellen an. Mit heiserer Stimme sagt sie: „Mir ist schlecht, und mir ist so schwindelig.“ Sie hat Bauchkrämpfe. Ihre Kollegin misst: Puls 128/min, Blutdruck 88/50 mmHg, Atemfrequenz 26/min, Sauerstoffsättigung 93 %. Sie notiert die Werte auf einem Zettel. Mia sagt, ihr Blutdruck sei sonst „immer so 120 zu 70“.

Informationstext B: Anaphylaktischer Schock

Bei Kontakt mit dem Allergen setzen Mastzellen schlagartig Histamin frei. Die Gefäße werden weit und durchlässig. Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus (Quaddeln, Schwellungen). Im Gefäßsystem fehlt dann Volumen → der Blutdruck fällt. Die Schleimhäute schwellen an, die Bronchien werden eng → Atemnot. Der Puls wird schnell.

Im Notfall: Allergen stoppen, Hilfe holen, nach Leitsymptom lagern. Adrenalin i. m. nach Anordnung oder SOP ist das Mittel der ersten Wahl.

Oft sind mehrere Organe betroffen: Haut (Juckreiz, Quaddeln, Schwellungen), Atemwege (Heiserkeit, pfeifende Atmung, Atemnot), Kreislauf (schneller Puls, niedriger Blutdruck, Schwindel) und Magen-Darm (Übelkeit, Bauchkrämpfe). Achtung: Die Haut kann auch blass sein.

Der anaphylaktische Schock ist eine schwere allergische Sofortreaktion, z. B. auf Medikamente, Insektengift oder Nüsse. Sie beginnt Sekunden bis Minuten nach dem Kontakt.

Pflegefachpersonen beobachten vor allem Atmung (Heiserkeit, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung) und Kreislauf. Nach Stunden kann eine zweite Reaktion folgen (zweigipfliger Verlauf). Deshalb ist eine Nachbeobachtung nötig.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: Allergen = Auslöser einer Allergie | Mastzellen = Abwehrzellen im Gewebe, die Histamin speichern | Quaddeln = juckende, erhabene Hautschwellungen | anaphylaktisch = durch eine schwere allergische Reaktion

Expertenblatt C · Neurogener Schock

Papierfassung (freiwillig): Die Aufträge, den Fall zum Markieren und den Experten-Check finden Sie in der Stunden-App auf Ihrem Handy. Hier können Sie Fall und Infotext zusätzlich auf Papier lesen und markieren.

Fallsituation

An einem Sonntagnachmittag sind Sie privat mit Freunden am Baggersee. Tobias Weber (24) springt kopfüber vom Steg ins Wasser – an einer Stelle, an der das Wasser nur hüfttief ist. Seine Freunde ziehen ihn sofort ans Ufer. Kurz vorher hatte er sich noch mit Sonnencreme eingecremt.

Herr Weber ist wach und sagt: „Ich spür meine Beine nicht. Und meine Hände kribbeln." Er klagt über starke Nackenschmerzen. Arme und Beine kann er kaum bewegen. Seine Atmung ist flach. Sie tasten einen langsamen Puls von 52/min. Die Haut an seinen Beinen ist warm, trocken und rosig. Er fragt, ob jemand sein Handy gesehen hat. Der Rettungsdienst misst später einen Blutdruck von 82/45 mmHg.

Informationstext C: Neurogener Schock

Beim neurogenen Schock ist der Blutdruck niedrig, aber der Puls langsam oder normal. Unterhalb der Verletzung ist die Haut warm, trocken und rosig. Dort bestehen Lähmungen und Gefühlsstörungen (Kribbeln). Oft hat die Person Nackenschmerzen. Bei hoher Verletzung ist auch die Atmung gestört. Achtung: Die Person wirkt „stabil", ist aber im Schock.

Pflegefachpersonen kontrollieren vor allem Atmung, Blutdruck, Puls, Körpertemperatur (Auskühlung) und Lähmungen im Verlauf.

Im Rückenmark verlaufen Nervenbahnen des Sympathikus. Sind sie unterbrochen, werden die Gefäße unterhalb der Verletzung weit. Das Blut „versackt" → der Blutdruck fällt. Der Puls steigt nicht, und es gibt keine Zentralisation.

Im Notfall: Notruf. Den Kopf mit beiden Händen in der vorgefundenen Lage halten, nicht bewegen. Wärme erhalten, Atmung und Puls überwachen.

Auslöser ist eine Verletzung des Rückenmarks, meist an der Halswirbelsäule – z. B. nach einem Kopfsprung in flaches Wasser oder einem Sturz aus der Höhe.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: neurogen = vom Nervensystem ausgehend | Rückenmark = Nervenstrang im Wirbelkanal | Sympathikus = Teil des Nervensystems, der Puls und Gefäßspannung steigert